

• 药物与临床 •

药物相互作用

九、抗震颤麻痹药	处 理
左旋多巴 • 其他抗震颤麻痹药:疗效加强,但精神病患者禁用。 • 肾上腺素能受体激动药:可诱发心律失常。 • 降压药:降压作用加强。 • 制酸药:减少左旋多巴吸收。 • 溴隐亭:加强疗效。 • 苯妥英:酶促作用使左旋多巴降效。 • 氟哌啶醇、罂粟碱、吩噻嗪类、硫杂蒯类(氯普噻吨)等:有阻滞脑组织中多巴胺受体致锥体外系反应的作用,加重帕金森病症状,而减弱左旋多巴作用。 • 食物:影响本品吸收。高蛋白食物生成的氨基酸影响本品进入中枢而降效。 • 甲氧氯普胺:增强消化道蠕动,促使本品提前入肠,增加吸收。 • 单胺氧化酶抑制剂(包括呋喃唑酮):与本品联用可致高血压危象。在服用本品前应提前 2~4 周停用 MAOI 类药物。 • M 受体阻滞药(阿托品等):减慢胃肠蠕动,减少消化液分泌,减少本品吸收。 • 维生素 B₆:加强多巴脱羧酶作用,使左旋多巴较多地在周围脱羧,进入中枢量减少,疗效减弱并增加周围副作用。但加有脱羧酶抑制剂的药物则不受影响,加服维生素 B₆ 反而增效。 金刚烷胺 • 乙醇:中枢不良反应增加。 • 抗胆碱药、抗组胺药、吩噻嗪类、三环抗抑郁药及其他抗震颤麻痹药:抗胆碱作用增强,对于有精神系统疾病的患者应特别注意。 • 中枢兴奋药:中枢兴奋性加强,可致惊厥或心律失常等。 苯海索 • 乙醇:中枢镇静作用加强。 • 抗胆碱药、其他抗震颤麻痹药、单胺氧化酶抑制剂:这些药物都有抗胆碱作用,联合应用效应增强,可致严重不良反应。 • 制酸药、吸附性止泻药:减少苯海索吸收。 • 左旋多巴:左旋多巴的效应可望增强。	应禁同用 应分别使用 减少左旋多巴用量 禁忌 食前服药 严格禁忌 维生素 B₆ 不宜与左旋多巴联用。但与含脱羧酶抑制的药物联用则有益。 禁忌 特别注意 禁忌 避免联用 精神病患者禁用
十、精神兴奋药	处 理
哌甲酯 • 中枢兴奋药、肾上腺素能受体激动药:中枢兴奋加强,致紧张、激动、失眠、乃至惊厥或心律失常。 • 抗高血压药(包括利尿降压药):效应减弱。 • 苯妥英、苯巴比妥、扑米酮:体内过程延长,血药升高,可致中毒。 • 双香豆类等:代谢受抑,可致出血。 • 三环抗抑郁药:代谢受抑、效能增强。 匹莫林 • 抗癫痫药:匹莫林使癫痫发作阈值降低,应调正用量。 • 中枢兴奋药:同哌甲酯。	避免联用 监测并加量 监测,减量 监测凝血功能 监测调整剂量

十一、镇痛药	处 理
麻醉镇痛药 - 全麻药、局麻药、吩噻嗪类、三环抗抑郁药及其他中枢抑制药：中枢抑制作用加强，可致呼吸抑制或低血压、便秘加剧等。 - 抗高血压药、利尿降压药、抗震颤麻痹药，以及利多卡因、硝酸酯类、普鲁卡因胺、奎尼丁等：与麻醉镇痛药联用可发生体位性低血压的危险。 - 林可霉素类及其他抗生素（尤其是广谱抗生素）：由于麻醉镇痛药使抗菌药物在肠腔内滞留，排出迟缓，有致假膜性肠炎的危险。 - 硫酸镁：中枢抑制作用（包括呼吸抑制，低血压）加重。 - 单胺氧化酶抑制剂（呋喃唑酮、丙卡马胍等）：与本类药物（尤其是哌替啶、芬太尼）致突发的激动、多汗、僵直、血压升高或降低、呼吸抑制、昏迷、惊厥、高热、甚至死亡。 - 喷他唑辛：喷他唑辛为阿片受体的部分激动-拮抗剂，与吗啡类药物联用在镇痛作用方面起拮抗作用，并增强不良反应。	应减量给药 注意监测、监护 注意肠道菌群变化，及时停药 监护预防意外 禁忌联用。必须在 MAOI 停用 2 周后方可用本类药物 禁忌
十二、中枢兴奋药	处 理
咖啡因 - 甲丙氨酯、异烟肼：提高咖啡因的脑组织浓度而增效。 - 口服避孕药：降低咖啡因清除率而使之增效。 多沙普仑 - 全麻药：多沙普仑使儿茶酚胺释放而增效。吸入性全麻药可使心肌对儿茶酚胺敏感而增效，因此宜停止全麻药后 10~20 分钟才能应用。 - 单胺氧化酶抑制剂（呋喃唑酮等）、升压药：与多沙普仑联用，血压升高作用增强。 - 肌松药：肌松药术后残余效应可掩盖本药的中枢兴奋作用。 - 中枢兴奋药、肾上腺素能受体激动药：中枢兴奋性加强可出现紧张、激动、失眠、惊厥和心律失常。	谨慎使用 谨慎使用 谨慎使用 谨慎、注意观察

(待续)

中成药新用举案

吴光维

1 巧用“二天油”止咳

半夜三更，咽喉瘙痒，频频咳嗽，气逆喉响，咳声吵耳，邻人受殃。用“红花牌二天油”外搽穴位并吸入其挥发气体，咳立停。

方法：①用药前先咳出咽喉中痰，擤净鼻涕；②将“二天油”1~2 滴，滴于胸骨上窝“天突”穴。用右手食指蘸在该处的药液涂于颈后“大椎”穴（该穴位于后正中线第七颈椎棘突下陷窝处）及旁开 0.5 寸的“定喘”穴；③再将 1 滴“二天油”涂于左手掌心“劳宫”穴（握手屈指时中指尖处是穴），用右食指将药涂开似 2 分硬币大小，左手各指并拢呈半握拳状，盖住口鼻，用口作深吸气 5 次，再改用鼻吸气 5 次，如此口、鼻轮流吸入几次，吸入其挥发气味后咽喉有辛凉快感，瘙痒异物感随之消失，约 1 分钟咳立停。

按语 广州群星药业公司生产的“红花牌二天油”原为驱风兴奋剂，由薄荷油及黑药油等配成。笔者用其外搽穴位并吸入其挥发气味治疗咳嗽，1 分钟咳立止。作用机制可能是该药对上呼吸道有解痉作用而能平喘镇咳，止咳作用之快实出意料，加上几

个穴位搽药，有宣肺化痰，利咽开音和定喘作用。

2 单味生大黄治胆绞痛

病例 患者女，56 岁。因胆结石于 1 年前作胆囊切除术，术后仍经常右上腹痛，复查胆道有胆砂存留，食肉及油炸类食品易发作，多为胀痛，也有剧烈疼痛伴呕吐，时有发热。用哌替啶（度冷丁），阿托品及抗菌药可缓解，但停药后仍多次发作。给生大黄 10 克煎服，1 小时后疼痛缓解，日大便 2 次。上述药量连服 3 天，患者自觉腹中十分舒坦，再连服 10 天。追踪随访半年不再发作。

按语 大黄出自《神农本草经》，其性味苦寒，入胃、大肠、肝经。有泻热毒、荡积滞、行瘀血之功。生用力猛，熟用力缓。用药后湿热清、郁滞通，“通则不痛”诸症自愈。据研究确认，大黄主要有效成分蒽醌类衍化物有抑菌作用，大黄酚对胆汁分泌有促进作用。

3 中华跌打丸治胃柿石

病例 男，40 岁。6 天前上山做工，不慎扭伤右踝关节，当天因饥渴而食生柿子 2 只，约 300 克（连皮吃）。当晚，上腹疼痛伴“恶心、呕吐。随后发作频繁，饥时痛甚，食后可暂缓解，在当地卫

作者单位：537214 广西壮族自治区桂平市大洋镇乐民诊所